Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

1VARCIVGUA
Vara Cível do Guará

Número do processo: 0700036-16.2025.8.07.0014

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR ESPÓLIO DE: EDILUCIA DE ARAUJO CANTANHEDE MATTOS
REPRESENTANTE LEGAL: VIVIAN CANTANHEDE MATTOS, A. F. C.
REU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Cominatória com Pedido de Tutela de Urgência, cumulada com indenização por Danos Morais, ajuizada por Edilúcia de Araújo Cantanhede Mattos, já qualificada nos autos (aposentada, beneficiária da Justiça Gratuita), em face da AMIL Assistência Médica Internacional S.A., com a causa estimada em R$ 81.937,68. A Autora, aderente ao plano de saúde AMIL Blue I NACIONAL QC R111 desde 16/12/2010, foi diagnosticada em janeiro de 2024 com leiomiomatose maligna, apresentando lesões metastáticas na região pré-sacral e pulmonar, com compressão cardíaca. Após o tratamento com o medicamento Anastrozol, que não obteve resposta clínica adequada, a doença progrediu. O médico assistente, Dra. Martha Tatiane Mesquita dos Santos (CRM: 12776/D), solicitou a medicação everolimus 5 mg/dia para uso contínuo, em 20/12/2024.

A solicitação médica (nº 90423828) foi negada pela Ré em 02/01/2025. A AMIL justificou a recusa alegando que o procedimento solicitado não preenchia as Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos Médicos da ANS, caracterizando uso "off-label".

A Autora sustentou em sua Petição Inicial que a negativa é indevida, pois a Lei nº 9.656/98, em seu Artigo 12, I, alínea “c”, garante a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral. Argumentou que a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS não deve prevalecer sobre a necessidade de tratamento oncológico, e que a recusa indevida é passível de gerar danos morais, requerendo indenização de R$ 15.000,00. A Autora postulou a concessão de tutela de urgência para o fornecimento imediato da medicação, sob pena de multa diária.

Em despacho inicial (ID 222141663), o Juízo determinou a comprovação da evidência científica do remédio para a doença. A Autora emendou a inicial anexando estudos científicos (ID 222141671 e 222141672)

que demonstravam a eficácia do everolimus ou inibidores de mTOR (como sirolimus) no tratamento de leiomiomas metastáticos, com Taxa de Controle da Doença (DCR) de 86,7% no estudo de Zhang et al. (2024).

Em 10/01/2025, o Juízo DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ID 222323185, conforme relato em 421), reconhecendo a probabilidade do direito (Art. 12, I, “c”, da Lei 9.656/98 e evidências científicas) e o perigo de dano (risco de progressão e óbito). Determinou que a Ré autorizasse e custeasse o medicamento everolimus 5 mg/dia no prazo de 5 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A Ré, AMIL Assistência Médica Internacional S.A., apresentou Contestação (ID 225401345, em 10/02/2025), alegando, em síntese: a ausência de negativa ilícita, a não obrigatoriedade de cobertura devido à falta de previsão do Everolimus 5mg na Diretriz de Utilização Técnica (DUT) nº 64 da ANS para a patologia da Autora (leiomiossarcoma com metástases); o Rol da ANS seria de cobertura mínima obrigatória (citando REsp nº 1.733.013 – PR); o uso seria off-label e, portanto, tratamento experimental, excluído pela Lei nº 9.656/98, Art. 10, I; e o ônus de custeio de medicamentos de alto custo caberia ao Estado (SUS), conforme Art. 196 da CF. A Ré negou a ocorrência de danos morais, argumentando mero descumprimento contratual.

Em 03/02/2025, a Ré informou o cumprimento da tutela de urgência (Pedido nº 429455300), mas a Autora noticiou que o fornecedor autorizado (4 BIO MEDICAMENTOS AS) estava com o estoque esgotado, com previsão de novo lote somente na primeira quinzena de fevereiro de 2025.

A Ré interpôs Agravo de Instrumento (nº 0704426-71.2025.8.07.0000) contra a decisão liminar. O Relator Des. Roberto Freitas Filho INDEFERIU o efeito suspensivo em 12/02/2025, mantendo a obrigação de fornecimento, destacando a necessidade de prevalência do Art. 35-C da Lei 9.656/98 em casos de urgência e o entendimento do STJ sobre a irrelevância do uso off-label para medicamentos registrados na ANVISA.

A Autora faleceu em 11/03/2025.

Em Réplica (ID 229356959), a Autora (por meio de sua advogada, antes da habilitação) informou o óbito e reiterou que o retardo injustificado na liberação da medicação (negativa em 02/01/2025, disponibilização em 12/02/2025, totalizando atraso superior a dois meses) comprometeu as chances de resposta ao tratamento e contribuiu significativamente para o agravamento do estado clínico da autora, reiterando o pedido de danos morais e citando precedentes do TJDFT e STJ favoráveis à cobertura off-label e à indenização em casos oncológicos.

O Juízo suspendeu o feito para habilitação dos herdeiros (ID 232111310). O Agravo de Instrumento interposto pela Ré foi JULGADO PREJUDICADO em 10/04/2025 pelo Tribunal, em razão da perda superveniente do objeto (falecimento da parte e cumprimento da tutela), mas ressalvando que a discussão sobre o mérito (custeio anterior ao óbito e danos morais) permaneceria nos autos principais.

Após a habilitação do Espólio de Edilúcia de Araújo Cantanhede Mattos (representado por Vivian Cantanhede Mattos e Alex França Cantanhede), o polo ativo informou que não possuía mais provas a serem produzidas, solicitando o julgamento de total procedência da ação. A Ré, por sua vez, solicitou o apoio do NATJUS e a produção de prova pericial médica, reiterando a ausência de indicação na DUT 64. O Ministério Público, intimado pela presença de incapaz, manifestou-se pela regularidade do processamento e pelo prosseguimento do feito, sem a necessidade de produção de outras provas.

É o relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A presente demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o contrato de plano de saúde configura típica relação de consumo. Assim, a interpretação das cláusulas contratuais, especialmente as limitativas de direito, deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor, conforme o Art. 47 do CDC.

Da Natureza do Contrato e da Obrigação de Cobertura do Tratamento Oncológico

A Autora, Edilúcia de Araújo Cantanhede Mattos, era portadora de leiomiomatose maligna com metástases, uma patologia grave classificada no grupo de Oncologia (C00-C97 D00-D09). O tratamento prescrito, Everolimus 5 mg/dia, é um antineoplásico oral.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, é clara em estabelecer a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e domiciliar. Conforme o Art. 12, inciso I, alínea "c", da Lei 9.656/98, a cobertura mínima exigida dos planos de assistência à saúde abrange os tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.

A tese jurídica da parte Autora/Espólio, que aqui se acolhe, é que a obrigação legal de cobertura de tratamento de câncer prevalece sobre quaisquer interpretações restritivas do contrato ou do Rol da ANS.

Da Recusa Baseada no Rol da ANS (DUT 64) e Uso “Off-Label”

A Ré AMIL centrou sua defesa na alegação de que o medicamento Everolimus 5mg, embora registrado na ANVISA, não estava previsto para a patologia específica da Autora (leiomiomatose maligna/leiomiossarcoma) na Diretriz de Utilização Técnica (DUT) nº 64 da ANS, caracterizando um uso off-label e, portanto, não obrigatório.

Tal argumentação não se sustenta diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por este Egrégio Tribunal, especialmente após a introdução do §13 ao Art. 10 da Lei nº 9.656/98.

Embora a legislação mais recente (Lei 14.454/2022) exija a comprovação de eficácia científica para tratamentos não previstos no Rol, a interpretação majoritária é de que, em se tratando de medicamento

registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o plano de saúde não pode inviabilizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, sob pena de esvaziar a própria finalidade do contrato.

O laudo médico (ID 221991445) e os relatórios anexados corroboraram a gravidade da enfermidade e a urgência na adoção do tratamento com Everolimus. A Dra. Martha Tatiane Mesquita dos Santos, profissional de confiança da paciente (médica assistente), indicou o fármaco como a única alternativa terapêutica viável após a progressão da doença com o tratamento anterior. A recusa, pautada em meros critérios administrativos e na alegação de uso off-label, configura conduta abusiva, uma vez que cabe ao médico e não à operadora definir a terapia mais adequada ao paciente.

Da Eficácia Científica e Dispensa de Perícia/NATJUS

A Ré requereu a produção de prova pericial e consulta ao NATJUS, visando subsidiar a análise da eficácia do fármaco para a patologia. Contudo, tal diligência mostra-se desnecessária e inócua no contexto atual do processo.

Em primeiro lugar, a Autora já havia cumprido a determinação judicial anterior, acostando evidências científicas que demonstram a eficácia de inibidores de mTOR, como o everolimus, para o tratamento de leiomiomas metastáticos. O Estudo de Zhang et al. (2024) (ID 222141671) e o Estudo de Elmaci et al. (2020) (ID 222141672) indicaram que o tratamento com everolimus (ou sirolimus) é uma opção robusta e promissora, com resultados clínicos de controle da doença (DCR de 86,7% no estudo de Zhang et al.).

Em segundo lugar, a pretensão da obrigação de fazer em si perdeu seu caráter continuado com o trágico falecimento da Autora em 11/03/2025. As questões remanescentes restringem-se à análise da legalidade da negativa inicial para fins de fixação de danos morais e à liquidação da obrigação de fazer pelo período em que foi cumprida. A produção de prova técnica neste momento não alteraria o juízo de valor acerca da abusividade da recusa à época do pleito, quando a urgência e a comprovação científica mínima já estavam presentes. Portanto, acolho o entendimento do Ministério Público e do Espólio, indeferindo a produção de prova pericial ou a consulta ao NATJUS.

Precedente:

> RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO OFF LABEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF.
>
> 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de linfoma linfoplasmocítico.
>
> 2. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
>
> 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal.
>
> 4. Recurso especial a que se nega provimento

(REsp n. 2.188.641/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Das Astreintes pelo Descumprimento da Tutela de Urgência

O Juízo, ao deferir a tutela de urgência em 10/01/2025, estabeleceu o prazo de 5 dias corridos para o fornecimento do medicamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Conforme os autos, a negativa administrativa se deu em 02/01/2025. A decisão liminar foi proferida em 10/01/2025 e, considerando a comunicação da liberação pela AMIL em 15/01/2025 (ID 225121289), a data limite para o cumprimento integral do fornecimento seria 5 dias após a intimação da Ré.

Apesar de a Ré ter autorizado o pedido em seu sistema (Pedido n° 429455300), a advogada da Autora informou que a empresa fornecedora (4 BIO MEDICAMENTOS AS) estava com o estoque esgotado, solicitando que a Ré providenciasse a compra por outro fornecedor. A Autora afirmou, em réplica, que o medicamento só foi efetivamente disponibilizado em 12/02/2025, configurando um atraso significativo na entrega de um medicamento essencial à vida.

Adotando-se o marco inicial de mora a partir do dia seguinte ao término do prazo judicial (21/01/2025) e o marco final da mora na data em que o medicamento foi efetivamente disponibilizado à Autora (12/02/2025), temos um período de 23 dias de descumprimento efetivo da obrigação de fornecer o medicamento (e não apenas de autorizar o seu fornecimento).

Cálculo da multa coercitiva (astreintes): 23 dias x R$ 1.000,00/dia = R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

A aplicação da multa se justifica pela necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial em tutela de urgência, conforme previsto no Art. 537 do Código de Processo Civil.

Dos Danos Morais

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a recusa indevida/injustificada de cobertura de tratamento por parte da operadora de plano de saúde enseja reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de angústia e aflição psicológica do beneficiário que se encontra em condição de extrema vulnerabilidade e fragilidade clínica, como no caso de tratamento oncológico.

A Autora era idosa e portadora de leiomiomatose maligna metastática, uma doença gravíssima. A negativa inicial da Ré (02/01/2025) e o posterior atraso efetivo no fornecimento do fármaco (até 12/02/2025), mesmo após ordem judicial, impuseram à paciente e sua família intensa angústia em um momento crítico, onde a morosidade e a burocracia contribuíram para o sofrimento e, segundo a parte Autora, comprometeram as chances de resposta ao tratamento, culminando em seu falecimento.

Não se trata, portanto, de mero descumprimento contratual, mas de conduta que violou o dever de boa-fé e, principalmente, o direito fundamental à saúde e à vida, tutelado pelo Art. 5º, caput, e pelo Art. 1º, III (dignidade da pessoa humana), da Constituição Federal.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observadas as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, em atenção aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Considerando a gravidade da doença, a responsabilidade da Ré pela recusa injustificada e a manutenção da angústia da Autora em seus últimos meses de vida, arbitro a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se mostra adequado para a compensação do sofrimento da vítima e para coibir a reiteração da conduta pela operadora.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, com fundamento no Art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados pelo Espólio de Edilúcia de Araújo Cantanhede Mattos em face de AMIL Assistência Médica Internacional S.A., para:

A. Confirmar a tutela de urgência concedida (ID 222323185, conforme relato em 421) e, em consequência, declarar a obrigação da Ré de custear integralmente o fornecimento do medicamento Everolimus 5 mg/dia pelo período de sua utilização pela Autora, conforme prescrição médica, em razão da abusividade da negativa inicial..

B. Condenar a Ré ao pagamento da multa coercitiva (astreintes) no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), em razão do descumprimento do prazo judicial para o fornecimento efetivo do medicamento (período de 23 dias de mora, calculado entre 21/01/2025 e 12/02/2025).

C. Condenar a Ré ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ), e de juros de mora pela SELIC – IPCA a partir da citação.

D. Condenar a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, que engloba a condenação por danos morais de R$ 6.000,00; o valor econômico da obrigação de fazer contido na inicial (valor da causa menos R$ 15.000,00 de danos morais) e 10% sobre o valor da multa astreintes, em conformidade com o Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital.

Alex Costa de Oliveira
Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: ALEX COSTA DE OLIVEIRA 25100809245915900000229 08/10/2025 09:24:59
https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

IMPRIMIR GERAR PDF